RUTA CLÍNICA: INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS - PEDIATRÍA

Ámbito: Consulta externa, Urgencias, Hospitalización

1. SOSPECHA CLÍNICA (SEGÚN EDAD y FACTORES DE RIESGO *)

CLÍNICA POR EDAD	+ FRECUENTE	- FRECUENTE
LACTANTES <3 MESES	-Fiebre -Vómito -Letargia -Irritabilidad	-Menor tolerancia vía oral -Dolor abdominal -Hematuria -Orina Fétida
>3 MESES PREVERBAL	-Fiebre -Vómito -Menor tolerancia VO	-Irritabilidad, letargia -Dolor abdominal -Hematuria -Orina Fétida
>3 MESES VERBAL	-Polaquiuria -Disuria -Incontinencia -Residuo miccional	-Malestar -Fiebre, vómito -Hematuria -Orina Fétida

FACTORES DE RIESGO

-Sexo femenino
-Vaciamiento vesical infrecuente
-Anomalías del tracto urinario
-Reflujo vesicoureteral
-Fimosis
-Disfunción del tracto urinario inferior
-Estreñimiento
-Instrumentación de la vía urinaria
-Contaminación perineal con flora intestinal
-Incontinencia fecal
-Exposición prolongada a heces en los pañales

2. DIAGNÓSTICO

CLÍNICA SEGÚN EDAD
+
NITRITOS + ESTERASA LEUCOCITARIA

POSITIVO

Determinar si requiere manejo hospitalario
-Antibioticoterapia
-Urocultivo

UROCULTIVO
-Punción suprapúbica ≥ 10.000 UFC/ml
-Cateterismo vesico ureteral > 50.000 UFC/ml
-Bolsa urinaria > 100.000 UFC /ml
-Micción espontánea ≥ 100.000 UFC/ml

AJUSTE DE TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO SEGÚN PATRÓN DE RESISTENCIA

Principales Agentes Etiológicos
-Escherichia coli
-Klebsiella pneumoniae
-Enterobacter spp.
-Enterococcus spp.
-Pseudomonas spp.

NEGATIVO

MICROSCOPIA

POSITIVO

NEGATIVO

Considerar otro diagnóstico

El diagnóstico de ITU siempre debe correlacionarse con la clínica; un uroanálisis alterado sin síntomas NO confirma infección

3. OTROS ESTUDIOS

3.1 SOLICITAR IMÁGENES EN:

<2 años primera IVU febril
2-6 años primera IVU febril sin respuesta a tratamiento
IVU atípica o recurrente
Palpación masa abdominal

4. CLASIFICACIÓN DE ITU

LUEGO DE CONFIRMACIÓN DX - HACER CLASIFICACIÓN DE ITU Y DEFINIR TTO PARENTAL

IVU BAJA (Cistitis)
Inflamación de mucosa vesical

NO COMPLICADA
Morfología y función renal normal

IVU ALTA (Pielonefritis)
Compromiso de la pelvis y parénquima renal

COMPLICADA
- Malformaciones nefro-urológicas
- Alteración mecánica
- Falta de respuesta al tratamiento
- Pielonefritis

SEGÚN EPISODIO

PRIMERA VEZ	PERSISTENCIA
Evaluar estructuralidad del tracto urinario	Evaluar y ajustar esquema de tratamiento

TRATAMIENTO IV EN:
Menores de 3 meses, fiebre elevada (≥38,5 °C) en niños de 3 a 6 meses, persistencia de la fiebre >48 horas pese al tratamiento indicado, compromiso del estado general o aspecto tóxico, vómito o intolerancia a la vía oral, deshidratación o mala perfusión periférica, elevación de reactantes de fase aguda, alteraciones electrolíticas o deterioro de la función renal.

5. TRATAMIENTO

5.1 TRATAMIENTO EMPÍRICO ORAL

CONDICIÓN	TRATAMIENTO 1° LÍNEA	DOSIS	TRATAMIENTO 2° LÍNEA	DOSIS
ITU baja	Cefalexina	75-100 mg/kg/día cada 6 horas	Amoxicilina-clavulanato	40-45 mg/kg/día cada 8-12 horas
ITU baja	TMP-SMX	8-10 mg/kg/día cada 12 horas	–	–
ITU baja	Nitrofurantoína	5-7 mg/kg/día cada 6 horas	–	–
ITU baja con factores de riesgo para microorganismos resistentes *	Amoxicilina-clavulanato	40-45 mg/kg/día cada 8-12 horas	TMP-SMX	8-10 mg/kg/día cada 12 horas
ITU alta	Cefalexina	75-100 mg/kg/día cada 6 horas	–	–
ITU alta	TMP-SMX	8-12 mg/kg/día cada 12 horas	–	–

5.2 TRATAMIENTO EMPÍRICO IV

CONDICIÓN	TRATAMIENTO 1° LÍNEA	DOSIS	TRATAMIENTO 2° LÍNEA	DOSIS
ITU baja	Cefazolina	100 mg/kg/día IV cada 6-8 horas	Amikacina *	15 mg/kg/dosis cada 24 horas Dosis máxima: 1000 mg/día
ITU baja			Gentamicina *	5-7 mg/kg/dosis cada 24 horas Dosis máxima: 2000 mg/día
ITU alta †	Cefazolina	100-150 mg/kg/día IV cada 8 horas Dosis usual: > 30 kg 750 mg IV cada 8 horas	Ceftriaxona	75-100 mg/kg/día cada 24 horas Dosis máxima en ITU: 2 g/día
ITU alta †			Amikacina *	15 mg/kg/dosis cada 24 horas
ITU Alta con factores de riesgo para microorganismos resistentes o por epidemiología local	Amikacina	15 mg/kg/dosis cada 24 horas	TMP-SMX	8-10 mg/kg/día cada 12 horas

Factores de riesgo de IVU resistente: uso reciente de antibióticos,, hospitalización previa, procedimiento invasivos, inmunosupresión

Realizado por: Elián Andrés Camacho Zafra - Médico Interno UPTC